2026年上半期

内科 Practice-Changing 論文 14選

— Less is More / 上流介入 / 予防医療進化 —

NEJM・Lancet・JAMA から厳選

Internal Medicine Highlights 2026 Q1

医師・研修医向け

2026年上半期の3つの潮流

Three Major Trends in Q1 2026

① Less is More

標準治療の引き算

- SMART-DECISION（β遮断薬中止）
- WISDOM（リスクベース乳がん検診）
- CTT（スタチン副作用）

② 上流介入

新規モダリティの躍進

- Iptacopan（補体）
- Olezarsen（APOC3）
- Semaglutide（MASH）
- Tezepelumab（TSLP）
- Treprostinil 吸入
- CHAMPION-AF（LAAC）

③ 予防医療

発症前・再発前介入

- Lenacapavir（HIV）
- Abatacept（RA前治療）
- Hydration（結石）
- FMT（CDI）

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

第１章

Less is More

― 標準治療の引き算 ―

SMART-DECISION ・ WISDOM ・ CTT (Statin)

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

1. 心筋梗塞後β遮断薬は中止してよいか

SMART-DECISION Trial

NEJM
2026/3/30

SMART-DECISION（Choi KH ら / 韓国）

対象（P）

心筋梗塞後 1年以上β遮断薬継続中、
LVEF ≥40% の安定患者
2,540例（平均63歳, 女性12.8%）

介入（I/C）

β遮断薬「中止」vs「継続」
中央値追跡 3.1年

主要結果（Result）

全死亡＋再梗塞＋心不全入院: 中止群 7.2% vs 継続群 9.0%（HR 0.80, 95%CI 0.57–1.13）
→「中止」の「継続」に対する 非劣性 を達成

💡 **Take-home: LVEFが保たれ安定した心筋梗塞既往患者では、1年以降のβ遮断薬中止は安全な選択肢**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

2. リスクベース vs 毎年マンモグラフィ

WISDOM Trial

JAMA
2026/3/3

WISDOM（Esserman LJ ら / 米国）

対象（P）

40～74歳の女性 28,372例
（リスクベース 14,212 vs 毎年 14,160）

介入（I/C）

個人リスクに応じた検診間隔 vs 一律毎年マンモ
中央値追跡 5.1年

主要結果（Result）

Stage IIB以上のがん発見率: リスクベース 30/10万人年 vs 毎年 48/10万人年
→ 非劣性。最高リスク層では Stage IIB+ ゼロ（=より早期検出）

💡 **Take-home: 個別化検診（precision prevention）が、過剰診断を減らしつつ進行がん検出を担保**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

3. スタチン副作用の大半はノセボ効果

CTT Collaboration Meta-analysis

Lancet
2026/2

CTT Collaboration（Reith C ら, Oxford）

対象（P）

スタチン vs プラセボ 二重盲検RCT 19試験
123,940例（中央値追跡 4.5年）

介入（I/C）

スタチン群 と プラセボ群 の有害事象を
個別患者データレベルで比較

主要結果（Result）

記憶障害・抑うつ・睡眠障害・性機能障害 → スタチンに起因しない
因果が確認されたのは 横紋筋融解・新規糖尿病・肝酵素上昇 など6項目のみ

💡 **Take-home: スタチン副作用の大半はノセボ効果。患者教育と再投与（rechallenge）戦略が重要**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

第 2 章

Upstream Intervention

― 病態上流への介入：新規モダリティ ―

Iptacopan ・ Olezarsen ・ Semaglutide ・ Tezepelumab ・ Treprostinil ・ CHAMPION-AF

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

4. IgA腎症に補体B因子阻害

APPLAUSE-IgAN 24-month

NEJM
2026/3/29

APPLAUSE-IgAN 24ヶ月最終データ（Barratt J ら）

対象（P）

原発性IgA腎症
（標準治療下でもタンパク尿持続）

介入（I/C）

補体B因子阻害薬 Iptacopan vs プラセボ
投与期間 24ヶ月

主要結果（Result）

年間eGFR低下: −3.10 vs −6.12 mL/min/1.73㎡（差 +3.02, p<0.001）
腎複合エンドポイント: 21.4% vs 33.5%（HR 0.57）。重篤感染 6.7% vs 2.1% に注意

💡 **Take-home: 補体副経路の直接阻害が、IgA腎症の進行をほぼ半減（ただし感染症対策必須）**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

5. APOC3標的で重症高TG血症と膵炎を抑制

CORE-TIMI 72 (Olezarsen)

NEJM
2026

CORE-TIMI 72a / 72b（Marston NA ら）

対象（P）

重症高トリグリセリド血症患者
（TG ≥500 mg/dL）

介入（I/C）

APOC3標的アンチセンスオリゴ Olezarsen
50/80mg
月1回 皮下注 vs プラセボ（12ヶ月）

主要結果（Result）

6ヶ月でTG値が大幅低下
急性膵炎 平均発症率比 0.15（95%CI 0.05–0.40, p<0.001）→ 約 85% 減

💡 **Take-home: mRNA標的の新世代モダリティが、難治性高TG血症の膵炎リスクをほぼゼロに**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

6. セマグルチドが MASH に有効

ESSENCE Trial

NEJM
2025/4

ESSENCE（Sanyal AJ ら）

対象（P）

MASH（代謝機能障害関連脂肪肝炎）
線維化Stage 2–3 / 1,197例

介入（I/C）

セマグルチド 2.4mg 週1回 皮下注 vs プラセボ
投与期間 72週

主要結果（Result）

線維化悪化なし MASH消失率: 62.9% vs 34.3%（差 +28.7%, p<0.001）
MASH消失＋線維化改善の同時達成: 32.7% vs 16.1%

💡 **Take-home: GLP-1受容体作動薬がMASH治療薬としての確固たる地位を獲得**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

7. 重症喘息の経口ステロイド離脱

WAYFINDER (Tezepelumab Phase 3b)

Lancet RM
2026/2

WAYFINDER（フェーズ3b・単群）

対象（P）

OCS依存性 重症喘息成人 298例
（プレドニン換算 5–40 mg/日）

介入（I/C）

TSLP阻害薬 Tezepelumab 210mg / 4週ごと SC
投与期間 52週

主要結果（Result）

52週時点で OCS ≤5 mg 達成: 89.9%
OCS 完全離脱: 50.3%（喘息コントロール悪化なし）

💡 **Take-home: TSLP阻害薬がOCS依存重症喘息の半数を「ステロイドフリー」に到達させる**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

8. 吸入Treprostinilが IPF の進行を抑制

TETON-2 Trial

NEJM
2026/3/11

TETON-2（Nathan SD ら）

対象（P）

特発性肺線維症（IPF）患者

介入（I/C）

吸入 Treprostinil 12吸入×4回/日 vs プラセボ
投与期間 52週

主要結果（Result）

FVC変化中央値: −49.9 mL vs −136.4 mL（差 +95.6 mL）
臨床的悪化イベント: 27.2% vs 39.0%

💡 **Take-home: PH-ILDだけでなく IPF 本体の進行を抑制。pirfenidone・nintedanibに次ぐ第3の選択肢**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

9. 左心耳閉鎖術 vs DOAC

CHAMPION-AF Trial

NEJM
2026/3/28

CHAMPION-AF（Leon MB ら / ACC.26）

対象（P）

長期DOAC可能な心房細動患者
3,000例

介入（I/C）

WATCHMAN FLX による LAAC 1,499例
vs DOAC 1,501例（3年追跡）

主要結果（Result）

心血管死＋脳卒中＋全身塞栓 → 非劣性
非手技関連出血: 10.9% vs 19.0%（45%減, p<0.001）優越性

💡 **Take-home: LAACが「DOAC不耐者の代替」から「DOAC候補患者でも選択肢の1つ」へシフト**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

第 3 章

Prevention Evolved

― 予防医療の進化：発症前・再発前介入 ―

PURPOSE-2 (Lenacapavir) ・ ALTO (Abatacept) ・ Hydration ・ FMT

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

10. 年2回注射でHIV感染をほぼゼロに

PURPOSE-2 Trial

NEJM
2024/11

PURPOSE-2（Lenacapavir 二重盲検RCT）

対象（P）

シスゲイ男性・トランスジェンダー等
3,265例（2:1割付）

介入（I/C）

長作用型カプシド阻害薬 Lenacapavir
26週ごと SC vs 毎日 FTC/TDF（PrEP）

主要結果（Result）

HIV発症率: Lenacapavir群 0.10/100人年（2例）
vs F/TDF群 0.93/100人年（9例）背景発症率より有意に低下

💡 **Take-home: 毎日服薬のアドヒアランス問題を根本解決。HIV予防の歴史的ブレイクスルー**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

11. 関節リウマチを発症前に「治療」する

ALTO (APIPPRA Long-term)

Lancet Rheum
2026/1

ALTO（APIPPRA Long-term Outcome）

対象（P）

抗CCP抗体陽性＋関節痛の RA発症ハイリスク群
213例

介入（I/C）

T細胞共刺激モジュレーター Abatacept
1年間 投与 vs プラセボ（4–8年追跡）

主要結果（Result）

1年治療で 治療終了後 最長4年にわたり RA発症が有意に遅延
広範な自己抗体プロファイルを持つ患者で特に有効

💡 **Take-home:「症状が出る前に治療」する Pre-emptive therapy の概念実証**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

12. 水分摂取で結石は再発予防できるか

Hydration Adherence Trial

Lancet
2026/3/21

Hydration trial（Desai AC ら / USDN）

対象（P）

尿路結石既往患者

介入（I/C）

スマート水筒・コーチング・インセンティブによる
水分摂取増加プログラム vs 通常ケア（2年）

主要結果（Result）

介入群で 尿量は有意に増加
しかし症候性結石再発率には 有意差なし

💡 **Take-home: 行動介入だけでは不十分。食事制限・薬物療法を含む包括的アプローチが必要**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

13. 再発性CDIにおけるFMT・微生物製剤

FMT for Recurrent C. difficile (Review 2026)

Reviews
2026

FMT vs 精製マイクロバイオーム製剤（FDA承認製剤の登場）

対象（P）

再発性Clostridioides difficile感染症
小児・成人

介入（I/C）

従来型FMT vs FDA承認の精製微生物製剤
（Fecal microbiota live-jslm / SER-109 等）

主要結果（Result）

小児ではFMT治癒率 約86%（単回 81%）
重篤有害事象 2.0% — 高い有効性と安全性が再確認

💡 **Take-home: CDIマイクロバイオーム治療の「使い分け」が整理される時代へ**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

14. Surviving Sepsis Campaign 2026

SSC 2026 Guideline

Crit Care Med
2026/4/1

SSC 2026（Prescott HC・Antonelli M 共同議長 / 23ヶ国69名パネル）

抗菌薬投与のタイミング

敗血症性ショック疑い → 1時間以内 を維持
敗血症（ショックなし）はリスク階層化で柔軟化

輸液蘇生

固定 30 mL/kg/h ではなく
動的指標による個別化

129ステートメント中 46が新規

Precision Medicine（免疫表現型ベース）への展望が
初めて明文化

低中所得国の文脈

パネリストの 38% が低中所得国出身
資源制約下の推奨も提示

💡 **Take-home: 1時間ルールは堅持しつつ、輸液・Precision Medicineで「個別化」へ進化**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

15. 病院前 全血輸血 vs 標準ケア

SWiFT Trial

NEJM
2026/3/17

SWiFT（Study of Whole blood in Frontline Trauma）

対象（P）

生命危険を伴う出血性外傷 616例
（救急航空機10機 / 19病院）

介入（I/C）

病院前 全血 2単位 輸血
vs 標準血液製剤輸血

主要結果（Result）

24時間以内の死亡 or 大量輸血の複合エンドポイントで
優越性なし

💡 **Take-home: プレホスピタル全血戦略のロジ・コストを見直す根拠（PDF原文「RePHILL-2」は誤記）**

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

14試験 × 3つの潮流 マッピング

Summary Table

潮流	代表試験	臨床への含意
Less is More	SMART-DECISION / WISDOM / CTT	漫然継続を見直し、個別化と引き算が標準へ
上流介入	Iptacopan / Olezarsen / Semaglutide / Tezepelumab / Treprostinil / LAAC	分子・デバイスで病態上流を直接攻撃
予防医療進化	Lenacapavir / Abatacept / Hydration	発症前・再発前介入と、行動介入の限界
重症ケア	SSC 2026 / SWiFT	個別化（Precision Medicine）への進化と再評価

© 2026 Internal Medicine Practice-Changing Papers

まとめ

- ✓「漫然と続ける標準治療」を引き算する研究が増加
- ✓ 補体・mRNA・長作用型注射など 病態上流のモダリティ が躍進
- ✓ 発症前 / 再発前 の能動的介入が新しい予防医療の柱に
- ✓ 1試験の結果だけでなく、対象集団・サブ解析を読み込むことが重要

Internal Medicine 2026 Q1 — End of Slides

参考文献は記事末尾を参照